Santé mondiale et santé en France

Comprendre les indicateurs, les contrastes entre populations et les grandes évolutions de la santé. Les ordres de grandeur sont ceux du cours ; les tendances et leurs conditions d'interprétation priment sur la mémorisation isolée des chiffres.

01 · Santé, santé publique et santé mondiale — p. 1
02 · OMD, ODD et pauvreté — p. 2
03 · Mesurer la santé : les indicateurs — p. 3
04 · Natalité, décès et variation des populations — p. 3
05 · Espérance de vie et pyramide des âges — p. 4
06 · Mortalité maternelle — p. 4
07 · Mortalité néonatale et infantile — p. 5
08 · Prévalence, incidence et personnes-temps — p. 5
09 · Transition épidémiologique — p. 6
10 · VIH et sida — p. 6
11 · Paludisme, tuberculose et émergences — p. 6
12 · Maladies cardiovasculaires et respiratoires — p. 7
13 · Cancers : incidence, mortalité et survie — p. 7
14 · Dépistage organisé et individuel — p. 9
15 · Grandes causes de décès en France — p. 9
16 · Inégalités de santé : ce qui est effectivement sourcé — p. 10
17 · Pièges QCM — confusions à éviter — p. 11
18 · Synthèse générale — l'essentiel du cours — p. 12
19 · Définitions et mots-clés — p. 12

01 Santé, santé publique et santé mondiale

L'OMS définit en 1946 la santé par le bien-être physique, mental et social, et non par la seule absence de maladie. Cette définition invite à considérer les conditions de vie, les environnements et les ressources des personnes.

La santé publique cherche à prévenir les maladies, surveiller les risques et améliorer la santé d'une population. La santé mondiale s'intéresse aux enjeux transfrontaliers : infections, ressources, inégalités, environnement et coopération entre pays. L'OMS coordonne et oriente, sans se substituer aux systèmes nationaux.

One Health (« Une seule santé ») relie les santés humaine et animale aux écosystèmes. Une zoonose, une maladie vectorielle ou l'antibiorésistance ne peut pas être étudiée uniquement dans un cabinet médical : les acteurs de terrain, vétérinaires et environnementaux sont également utiles.

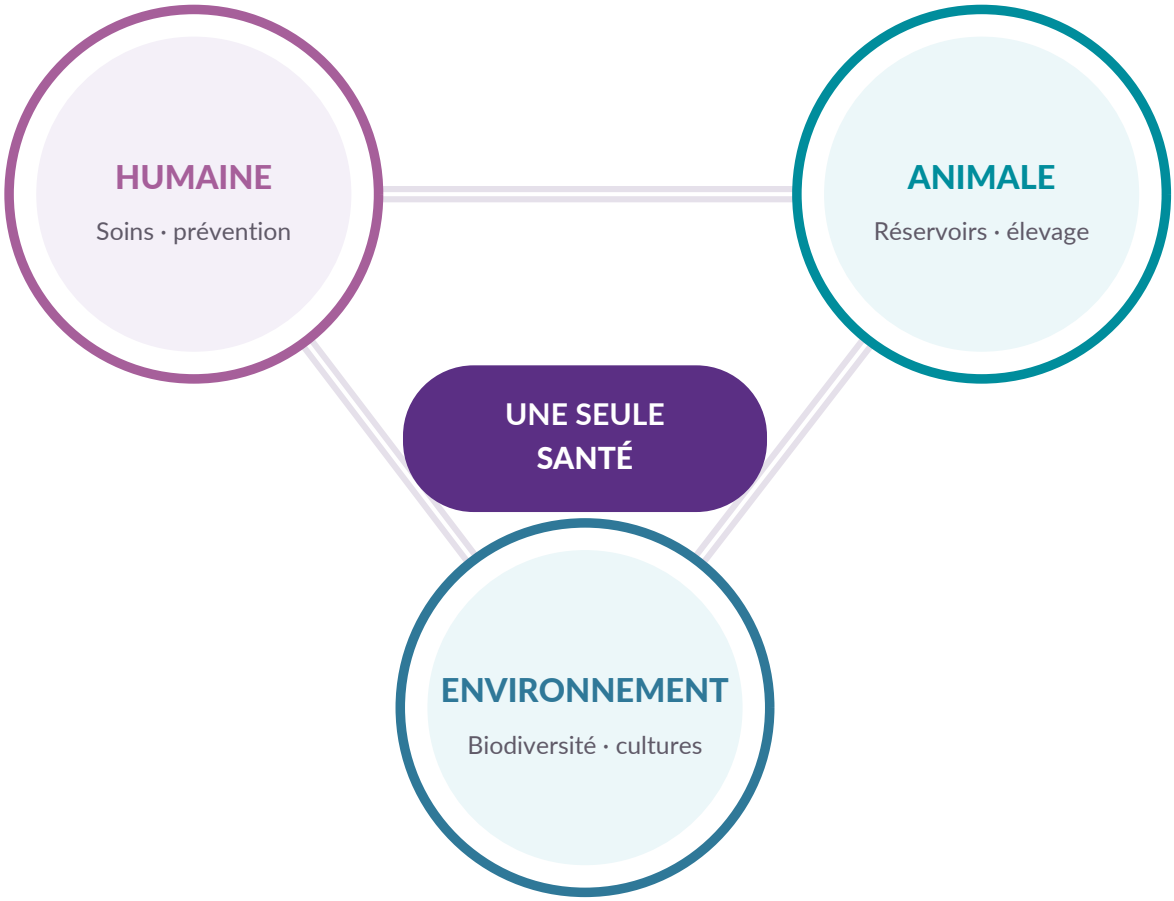
Schéma « Santé globale » (diapo 16, source citée dans le support) : la démarche relie les personnes (déterminants sociaux et systèmes de santé), la planète (mondialisation et santé des écosystèmes), les priorités (données probantes, collaboration internationale) et les politiques/pratiques (partenariats et interventions). Ces quatre axes sont présentés comme un cadre d'action pour la « santé pour tous ».

Cette démarche articule plusieurs niveaux d'action : définir des priorités et des politiques à une échelle internationale ou nationale, puis les traduire en interventions adaptées aux communautés locales. Les échanges entre pays et les changements environnementaux relient les situations locales à des enjeux qui dépassent les frontières.

Illustrations chiffrées de la diapo 15, à replacer dans leur source : 60 % des maladies infectieuses humaines y sont indiquées d'origine animale ; les maladies animales représentent 20 % de pertes de production animale ; 75 % des espèces végétales cultivées ont besoin de pollinisateurs ; 40 % des pertes de cultures vivrières y sont attribuées aux maladies/ravageurs. Ce sont les ordres de grandeur du visuel de cours, non des données contrôlées en 2026.

Notion	Question fondamentale
Soin individuel	Comment protéger et soigner cette personne ?
Santé publique	Comment prévenir et réduire les risques dans une population ?
Santé mondiale	Comment traiter des risques et déterminants dépassant les frontières ?
One Health	Comment agir ensemble sur humains, animaux et milieux ?

À retenir Une amélioration de la santé mondiale n'efface pas les inégalités entre territoires ni entre groupes sociaux.



02 OMD, ODD et pauvreté

OMD (2000–2015) : huit objectifs, dont réduction de la pauvreté, amélioration de la santé maternelle et infantile et lutte contre les grandes infections. Le cours rappelle des progrès considérables mais inégaux.

ODD (2015–2030) : dix-sept objectifs de développement durable. L'ODD 3 vise la santé et le bien-être à tous les âges. Certaines cibles sont chiffrées (mortalité maternelle, néonatale, avant cinq ans).

Un seuil de pauvreté se comprend uniquement avec sa devise, son unité par personne et par jour, l'année, la méthode et le champ géographique. Le support cite, pour son millésime, environ 9,8 % de la population mondiale sous un seuil de 3 dollars/jour. Une proportion en baisse peut coexister avec un effectif très élevé.

Autres repères du support (diapos 23–25) : environ un quart de la population mondiale vit avec moins de 5 $/jour, la moitié sous 10 $/jour et 80 % sous 30 $/jour, selon les définitions affichées. Une cible présentée pour 2030 mentionne aussi l'éradication de l'extrême pauvreté définie sur cette diapositive par un seuil de 1,25 $/jour ; ce seuil ne doit pas être mélangé avec celui de 3 $/jour utilisé ailleurs dans le cours.

Le seuil choisi change la population décrite : relever le seuil augmente la part de personnes considérées comme pauvres. Ces montants ne se convertissent pas en euros par simple assimilation ; il faut conserver la méthode de comparaison et le millésime du graphique. Le financement des actions compte également : le graphique d'aide publique au développement du support montre un recul en 2024 vers le niveau de 2015, sans établir à lui seul une cause politique unique.

À retenir Une cible annoncée pour 2030 n'est ni un résultat déjà observé ni une prédiction certaine.

03 Mesurer la santé : les indicateurs

Un indicateur est une mesure résumée permettant de décrire, quantifier, surveiller et comparer l'état de santé d'une population ou d'évaluer une politique publique.

Pour comparer deux populations, il faut aussi vérifier comment les événements ont été recueillis. L'état civil, le recensement et les autres données administratives permettent de compter les naissances, les décès et les habitants. Un recueil incomplet ou différent peut limiter la comparaison, même lorsque les indicateurs portent le même nom. Les indicateurs démographiques portent sur les naissances, décès, âges et l'espérance de vie. Les indicateurs épidémiologiques concernent la fréquence, la distribution ou l'évolution de maladies et facteurs de risque.

Pour interpréter un taux, préciser : numérateur, dénominateur, période, territoire, unité, structure par âge et méthode de recueil.

Mesure	Question posée	Unité
Effectif	Combien d'événements ?	Nombre
Proportion	Quelle part de la population ?	%
Taux brut	Combien rapportés à une population sur une durée ?	‰, /100 000
Taux standardisé	Que vaut la comparaison à structure d'âge comparable ?	Selon indicateur

À retenir Ne compare pas directement des taux bruts provenant de populations très différentes par âge sans discuter la standardisation.

04 Natalité, décès et variation des populations

Le solde naturel est le nombre de naissances moins le nombre de décès. À l'échelle d'un pays, la variation totale inclut aussi le solde migratoire. Une population peut continuer à augmenter alors que son taux de croissance diminue.

Le point essentiel est de distinguer les tendances : une population mondiale encore croissante peut croître de moins en moins vite. Dans les exemples de la séance, les naissances et les décès sont proches en France, tandis que les naissances restent plus nombreuses à l'échelle mondiale. Les projections décrivent une évolution possible ; elles ne sont pas un résultat déjà observé. Les chiffres exacts servent surtout à comprendre les ordres de grandeur.

Dans le monde, le support présente environ 132 millions de naissances et 61,7 millions de décès pour 2023, soit environ +70,3 millions de solde naturel. Pour la France, il affiche environ 639 000 naissances et 616 000 décès. Le périmètre exact de ces séries doit être précisé avant toute comparaison.

Taux brut de natalité = naissances vivantes / population de référence × 1 000 ; taux brut de mortalité = décès / population de référence × 1 000. Le support (2023) présente natalité : monde 16,3 ‰ / France 9,6 ‰ ; mortalité : monde 7,6 ‰ / France 9,3 ‰. Ces chiffres et les effectifs illustratifs ne proviennent pas nécessairement de séries au périmètre identique : ne pas recalculer un taux en les mélangeant.

À retenir Le taux de mortalité brut peut être élevé dans une population âgée sans que son système de soins soit moins performant.

05 Espérance de vie et pyramide des âges

L'espérance de vie à la naissance est calculée pour une génération fictive soumise aux conditions de mortalité de l'année étudiée ; elle ne prédit pas le décès d'une personne née cette année-là. L'espérance de vie à un âge donné porte sur les années restantes pour les personnes ayant déjà atteint cet âge.

Les repères de la séance pour la France en 2023 indiquent environ 85,7 ans pour les femmes et 80,0 ans pour les hommes. Ces valeurs sont datées ; le cours projette aussi une tendance générale à l'allongement de la vie.

Une pyramide des âges présente la population par âge et sexe. Une base large traduit une natalité importante ; une base plus étroite et des étages supérieurs plus fournis évoquent un vieillissement.

À retenir Le vieillissement joue sur les taux bruts. Pour interpréter un écart entre pays, raisonner sur la structure par âge.

06 Mortalité maternelle

Un décès maternel est lié à la grossesse, aggravé par elle ou par sa prise en charge, survenu pendant la grossesse ou dans les 42 jours suivant sa fin. Les causes accidentelles ou fortuites sont exclues. Ne pas confondre avec la mortalité néonatale, dont le seuil d'âge est inférieur à 28 jours.

Le rapport de mortalité maternelle est exprimé pour 100 000 naissances vivantes. Il ne faut pas le confondre avec le taux maternel rapporté aux femmes en âge de procréer et à une durée. Les plus fortes charges décrites se situent notamment dans des pays d'Afrique et d'Asie, en lien avec des inégalités d'accès aux soins obstétricaux et de ressources.

Le support cite pour 2023 environ 260 000 décès maternels dans le monde, soit environ 712 par jour. Cela correspond mathématiquement à un décès toutes les deux minutes, et non à deux décès par minute. La cible ODD 3.1 pour 2030 est un rapport mondial inférieur à 70 pour 100 000 naissances vivantes.

À retenir Repères : 42 jours ; dénominateur du RMM = naissances vivantes ; cible ODD = objectif 2030.

REPÈRES CHIFFRÉS DE LA SÉANCE

MONDE · 2023

≈ 200

/100 000 naissances

RMM du support

MONDE · 2023

≈ 260 000

décès maternels

≈ 712 par jour

CIBLE · 2030

< 70

/100 000 naissances

objectif, pas résultat

ÉVOLUTION ET CONTRASTES

2000 → 2023

Baisse du rapport mondial présentée :

– 40 %

Carte du cours

Les niveaux régionaux sont contrastés ; l'Afrique ressort nettement dans la figure. Les écarts ne se résument pas au total mondial.

07 Mortalité néonatale et infantile

Néonatale : décès de la naissance au 27e jour révolu, donc avant 28 jours. Infantile au sens Insee : décès avant un an. La mortalité des moins de cinq ans couvre une période plus large et ne doit pas être appelée « mortalité infantile » sans préciser la définition de la source.

Pour les comparaisons internationales, les nombres de décès sont rapportés le plus souvent à 1 000 naissances vivantes. Le cours donne pour les ODD 2030 les cibles d'au plus 12 décès néonatals pour 1 000 et 25 décès avant cinq ans pour 1 000. Les cibles ne prouvent pas leur réalisation.

La lecture des courbes porte aussi sur la vitesse du progrès : dans les séries du cours, la mortalité des enfants diminue, mais cette diminution ralentit après 2015. Le recul de la mortalité néonatale est moins rapide que celui de la mortalité avant cinq ans. Une amélioration ne signifie donc ni disparition des écarts entre régions ni atteinte automatique des objectifs de 2030.

À retenir Ne pas échanger fenêtre du décès maternel (grossesse et 42 jours après sa fin) et âge de décès néonatal (0–27 jours).

08 Prévalence, incidence et personnes-temps

La prévalence mesure la proportion de personnes ayant la maladie à un instant donné (ou pendant une période définie). L'incidence cumulée mesure la proportion de personnes initialement à risque qui développent la maladie sur une période. Le taux d'incidence met les nouveaux cas en rapport avec le temps-personne total de suivi.

Exemple du cours : 100 personnes suivies pendant deux ans avec neuf nouveaux cas : l'incidence cumulée illustrative est de 9 % sur deux ans si les 100 personnes étaient initialement à risque et que les conditions de suivi sont celles du schéma. Cela n'implique pas un taux annuel de 4,5 % ni neuf cas par 100 personnes-années sans connaître le suivi réellement cumulé.

Pour le taux d'incidence, chaque personne contribue au temps pendant lequel elle reste suivie et à risque de devenir un nouveau cas. Le suivi ne doit pas être supposé identique pour tous : survenue de l'événement et sorties de suivi peuvent le raccourcir. Dans l'exemple simplifié où quatre personnes deviennent malades exactement à un an et les quatre-vingt-seize autres sont suivies deux ans, le total est 4 × 1 + 96 × 2 = 196 personnes-années. Si cinq nouveaux cas supplémentaires apparaissent exactement à la fin de la deuxième année, le calcul est 9/196 par personne-année ; le dénominateur est une durée cumulée, et non 196 personnes devenues malades.

Indicateur	Numérateur	Dénominateur
Prévalence ponctuelle	Tous les cas présents	Population à la date T
Incidence cumulée	Nouveaux cas sur la période	Personnes à risque au départ
Taux d'incidence	Nouveaux cas	Somme des personnes-temps

À retenir Attention : prévalence = stock de cas ; incidence = nouveaux cas ; taux d'incidence = nouveaux cas / temps-personne.

09 Transition épidémiologique

Le cours rappelle la diminution de nombreuses maladies transmissibles sous l'effet combiné de l'assainissement, de meilleures conditions de vie, de la vaccination et des traitements anti-infectieux. La part relative des maladies non transmissibles (MNT) augmente, notamment les maladies cardiovasculaires, cancers, diabète et maladies respiratoires chroniques.

Cette évolution n'est pas identique partout : les régions diffèrent par les déterminants sociaux, l'accès aux soins et l'exposition aux risques. Les maladies transmissibles restent présentes et peuvent réémerger ; les MNT ne sont pas réservées aux pays riches.

Le taux de létalité décrit la proportion de malades qui décèdent de la maladie dans une période/une population définie ; il se distingue de la mortalité rapportée à la population générale.

À retenir Une maladie transmissible peut rester très fréquente alors que les MNT représentent la majorité des décès dans une population donnée.

10 VIH et sida

Le VIH est le virus de l'immunodéficience humaine, qui compromet notamment la fonction des lymphocytes T CD4. Le sida désigne un stade avancé de l'infection, pas un deuxième virus. Les traitements antirétroviraux (ARV) empêchent la réplication virale et permettent une prise en charge au long cours, sans constituer une guérison virologique habituelle.

La PrEP, prophylaxie avant une exposition à risque, et le TPE, traitement post-exposition. Le principe I = I concerne l'absence de transmission sexuelle du VIH lorsque la charge virale reste durablement indétectable sous traitement efficace ; il ne signifie pas absence de virus dans le corps.

À retenir VIH ≠ sida ; la PrEP se situe avant une exposition et le TPE après une exposition.

11 Paludisme, tuberculose et émergences

Le paludisme est une infection parasitaire due à des Plasmodium, notamment P. falciparum, transmise principalement par un moustique du genre Anopheles. La prévention vise les piqûres, avec mesures vectorielles ; les formes graves nécessitent une prise en charge rapide. Des transmissions mère-enfant ou par transfusion sont possibles mais non principales.

La tuberculose est due à Mycobacterium tuberculosis. Une infection latente est non contagieuse ; une maladie active pulmonaire peut transmettre la bactérie par voie aérienne. Le traitement nécessite plusieurs médicaments sur une durée prolongée ; une mauvaise observance favorise les résistances.

Le cours cite également Ebola, Zika, chikungunya, grippe aviaire et COVID-19 pour montrer qu'une maladie émergente ou réémergente reste un enjeu de surveillance. Les nombres historiques et létalités indiqués sont dépendants du contexte, de la période et de la définition des cas.

À retenir Ne pas confondre agent (virus, bactérie, parasite), vecteur (moustique), réservoir et mode de transmission.

12 Maladies cardiovasculaires et respiratoires

Les maladies cardiovasculaires comprennent notamment AVC, cardiopathies ischémiques dont infarctus du myocarde, et maladies thromboemboliques veineuses dont embolie pulmonaire. L'HTA et les dyslipidémies sont des facteurs de risque ; certaines maladies sont également liées entre elles par leurs complications.

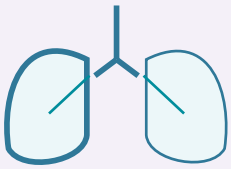
TROIS ENTITÉS CITÉES DANS LA SYNTHÈSE FINALE



AVC
Accident vasculaire cérébral



INFARCTUS
Du myocarde



EMBOLIE
Pulmonaire

Repères cités par l'enseignant, sans classement entre ces trois affections.

La dernière diapositive nomme AVC, infarctus et embolie pulmonaire comme trois entités à connaître. Cette liste de révision ne doit pas être interprétée comme un classement épidémiologique exhaustif et indépendamment vérifié des causes de décès.

Les maladies respiratoires du cours comprennent BPCO, asthme, bronchiolite, grippe, pneumonies et tuberculose. Une maladie fréquente n'est pas nécessairement très létale ; raisonner séparément en incidence, morbidité et mortalité.

À retenir Comparer les catégories cardiovasculaires et respiratoires demande d'identifier le mécanisme et le niveau de classification.

13 Cancers : incidence, mortalité et survie

L'incidence des cancers décrit les nouveaux diagnostics sur une période. La mortalité compte les décès. La survie nette standardisée cherche à estimer la survie liée au cancer en tenant compte d'autres causes de décès dans une modélisation spécifique. Ces indicateurs répondent à des questions différentes.

TOTAL DES NOUVEAUX CAS (2023)

433 136



Femmes : 187 526 · 43 %
Hommes : 245 610 · 57 %

FEMMES · 68 ans (âge médian)

HOMMES · 70 ans (âge médian)

CHEZ LES FEMMES

Nouveaux cas selon les 4 sites affichés

Sein	61 214
Côlon-rectum	21 370
Poumon	19 339
Pancréas	7 668

Mêmes unités · données du cours 2023

CHEZ LES HOMMES

Nouveaux cas selon les 4 sites affichés

Prostate	59 885
Poumon	33 438
Côlon-rectum	26 212
Pancréas	8 323

Mêmes unités · données du cours 2023

Le support officiel cite environ 433 136 nouveaux cancers en France en 2023, dont 187 526 chez les femmes et 245 610 chez les hommes. Les principales localisations présentées en incidence sont chez les femmes : sein (61 214), côlon-rectum (21 370), poumon (19 339), pancréas (7 668) ; chez les hommes : prostate (59 885), poumon (33 438), côlon-rectum (26 212), pancréas (8 323). Ces listes sont des extraits des graphiques, pas un classement exhaustif des cinq cancers demandés.

La variation annuelle moyenne affichée dans le graphique porte sur un taux standardisé, pas directement sur le nombre brut de cancers. Il faut lire la période de chaque ligne : la prostate est présentée sur 2010–2018, les autres localisations sur 2019–2023. Le sens d'une variation ne doit donc pas être généralisé à toutes les localisations, à tous les indicateurs ou à une période unique.

La synthèse demande les cinq cancers les plus fréquents et les cinq les plus mortels. Il faut distinguer cette demande des données réellement détaillées : la diapositive d'incidence sélectionne quatre localisations par sexe ; la diapositive de mortalité en présente cinq par sexe. Ces données ne constituent pas, à elles seules, deux classements exhaustifs tous sexes confondus.

Dans la figure de mortalité du cours, les cinq localisations affichées chez les femmes sont : sein (12 765 décès), poumon (10 699), côlon-rectum (8 007), pancréas (6 730) et ovaire (3 420). Chez les hommes : poumon (20 468), prostate (9 002), côlon-rectum (8 923), pancréas (6 645) et foie (6 272). Ces effectifs sont ceux de la diapositive, étiquetée 2023 ; ils ne sont pas une actualisation épidémiologique. Il ne faut pas additionner seulement ces listes pour prétendre obtenir un classement national complet.

À retenir Fréquence ne dit rien, à elle seule, de la gravité ou de la mortalité : un cancer très fréquent n'est pas forcément le plus meurtrier.

14 Dépistage organisé et individuel

Le dépistage organisé s'adresse à des groupes cibles définis selon les programmes publics et leurs critères (âge, etc.), avec invitation et parcours organisé. Le dépistage individuel est discuté dans le cadre d'une relation clinique en fonction de facteurs de risque personnels et antécédents. Ne pas confondre un dépistage d'une personne asymptomatique et un examen diagnostique motivé par des symptômes.

Il faut préciser le cancer concerné, la population cible, l'examen, les bénéfices et les limites du programme plutôt que de considérer tout dépistage comme systématiquement nécessaire ou identique pour tous.

Les trois cancers cités dans la séance pour le dépistage organisé sont le sein, le côlon-rectum et le col de l'utérus. Le raisonnement individuel peut tenir compte d'un risque familial ou d'une prédisposition identifiée. Retenir ici la différence de démarche ; les âges, examens et intervalles ne sont pas déduits de ces seuls exemples.

À retenir Deux modalités à distinguer dans les QCM : organisé (cible populationnelle) et individuel (indication clinique personnalisée).

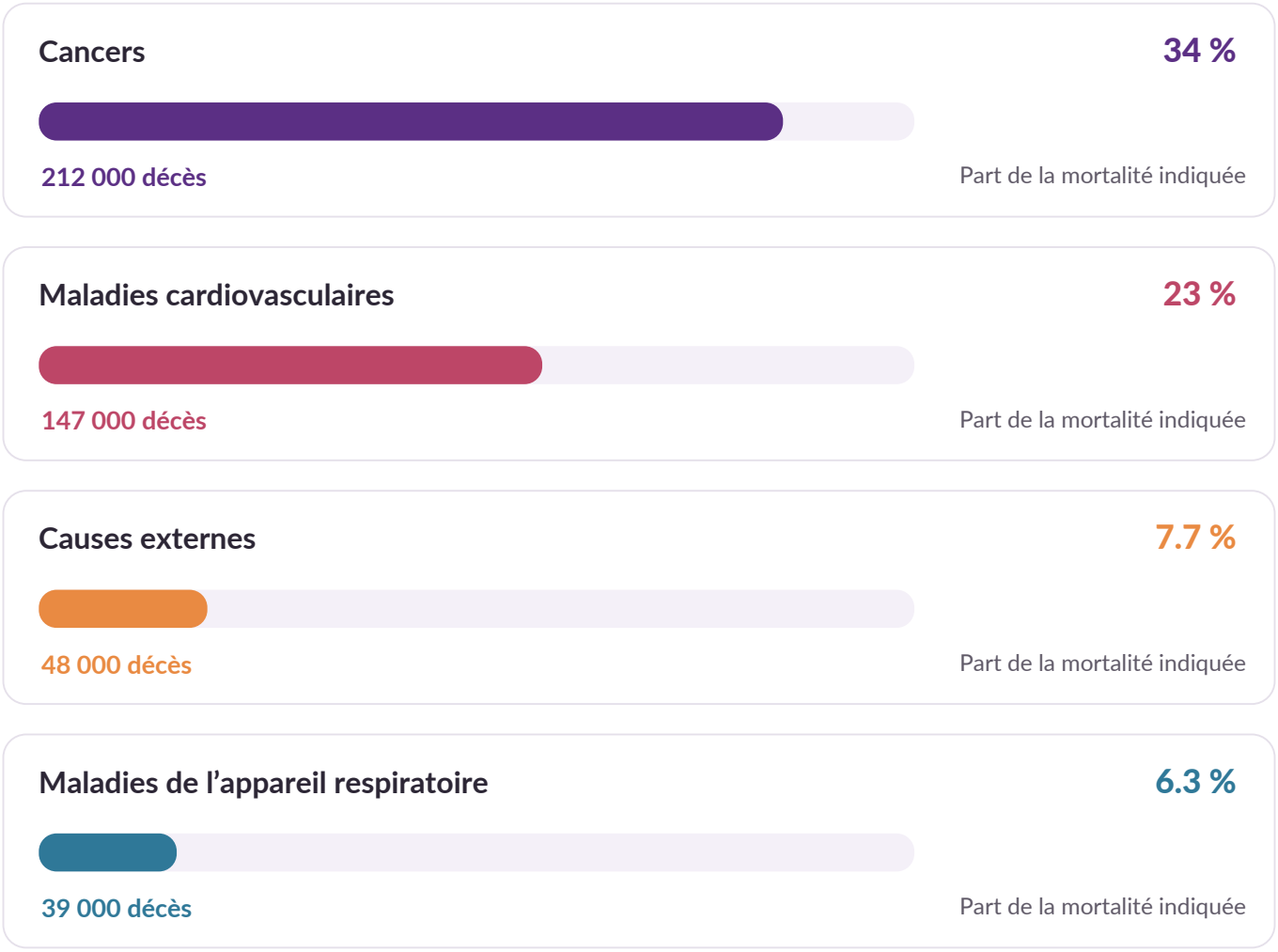
15 Grandes causes de décès en France

Le cours présente, pour un millésime annoncé 2023, des valeurs indicatives : cancers 34 % (212 000), maladies cardiovasculaires 23 % (147 000), causes externes 7,7 % (48 000), appareil respiratoire 6,3 % (39 000). Ce sont les valeurs du support, qui comporte une référence bibliographique à des données d'un autre millésime : ne pas les actualiser ou les fusionner sans contrôler la source d'origine.

D'après ce support, les cancers forment la première grande cause de décès dans l'ensemble des sexes réunis, alors que les maladies cardiovasculaires sont indiquées comme première grande cause chez les femmes. Les catégories exactes, les années de référence et les classifications nécessitent d'être conservées pour interpréter correctement cette distinction.

À retenir Préciser systématiquement « données du cours » et l'année : ce tableau n'est pas un bilan épidémiologique réactualisé en 2026.

PROPORTION DES DÉCÈS PAR GRANDE FAMILLE



16 Inégalités de santé : ce qui est effectivement sourcé

Le support présente des inégalités entre régions et niveaux de revenu : mortalité maternelle, mortalité des enfants, maladies transmissibles et non transmissibles ne se répartissent pas uniformément. Il rappelle le rôle des ressources, de l'hygiène, du contexte social et de l'organisation de la prévention.

L'exemple des moustiquaires illustre une distinction essentielle : connaître un moyen de prévention ne suffit pas si la personne ne dispose pas des ressources matérielles pour l'utiliser. Les inégalités de prévention ne s'expliquent donc pas uniquement par un manque d'information. L'action collective peut aussi porter sur la disponibilité des moyens de protection.

Cette séance décrit le panorama de la santé mondiale et de la santé en France. Les déterminants et inégalités de santé, les besoins, l'accès, le recours aux soins et la littératie en santé seront développés dans une autre séance de l'UE C1. Les contrastes territoriaux et les exemples de prévention présentés ici permettent de les introduire sans remplacer ce cours distinct.

Risque d'erreur	Réflexe utile
Comparer pays riches et pauvres en valeur absolue	Vérifier population, structure d'âge, année et indicateur
Dire qu'un progrès global signifie égalité	Rechercher les écarts territoriaux ou sociaux

Confondre besoins, accès et recours	Ne pas supposer que toute possibilité de soins entraîne un usage effectif.

À retenir Les écarts décrits par le cours sont des constats contextualisés, pas une opposition uniforme entre « Nord » et « Sud ».

17 Pièges QCM — confusions à éviter

Piège	Correction courte
1. Santé ≠ absence de maladie	L'OMS inclut physique, mental et social.
2. ODD ≠ résultat obtenu	Une cible 2030 n'est pas une valeur observée.
3. Effectif ≠ taux	Un plus grand nombre ne signifie pas un risque individuel plus élevé.
4. Taux brut ≠ taux standardisé	La structure par âge peut changer la comparaison.
5. Solde naturel ≠ variation totale	L'immigration et l'émigration interviennent à l'échelle nationale.
6. Espérance de vie ≠ pronostic personnel	C'est une table de mortalité de période sur une génération fictive.
7. Décès maternel ≠ néonatal	42 jours après la fin de grossesse versus 0–27 jours de vie.
8. RMM ≠ taux maternel	Naissances vivantes versus femmes en âge de procréer avec durée.
9. 712 décès/j ≠ 2 décès/min	712 / 1 440 ≈ 0,49/min : environ un toutes les deux minutes.
10. Prévalence ≠ incidence	Cas présents à T versus nouveaux cas sur période.
11. Incidence cumulée ≠ taux d'incidence	Personnes initialement à risque versus personnes-temps.
12. VIH ≠ sida	Virus versus stade avancé de l'infection.
13. Latence TB ≠ tuberculose pulmonaire active	La latence n'est pas contagieuse.
14. Incidence cancer ≠ mortalité	Le classement fréquent n'est pas celui des cancers les plus mortels.
15. Dépistage organisé ≠ individuel	Cible populationnelle versus indication individualisée.
16. Catégories cardiovasculaires ≠ classement exhaustif	AVC, infarctus et embolie sont cités, sans hiérarchie universelle démontrée.

18 Synthèse générale — l'essentiel du cours

Axe	À mémoriser
SANTÉ	Bien-être physique, mental, social ; santé mondiale et One Health sont multifactorielles.
OBJECTIFS	OMD 2000–2015 ; ODD 2015–2030 ; ODD 3 = santé et bien-être.
DÉMOGRAPHIE	Solde naturel = naissances − décès ; ne pas confondre effectifs et taux.
MORTALITÉ	Maternelle 42 jours, RMM /100 000 naissances ; néonatale <28 j, infantile <1 an.
ÉPIDÉMIOLOGIE	Prévalence = cas présents ; incidence = nouveaux cas ; taux d'incidence = nouveaux cas / personnes-temps.
TRANSITION	Les MNT augmentent en part relative ; les infections persistent et peuvent réémerger.
INFECTIONS	VIH ≠ sida ; paludisme vectoriel ; tuberculose latente non contagieuse.
CANCERS	Incidence, mortalité, survie et dépistage sont des notions distinctes.
FRANCE	Comprendre les tendances et les écarts ; replacer les ordres de grandeur du support dans leur période et leur périmètre.

Méthode finale À l'épreuve : identifier ce qui est compté, chez qui, sur quelle période, avec quel dénominateur et dans quelle unité.

19 Définitions et mots-clés

Santé (OMS)	Bien-être physique, mental et social ; pas seulement absence de maladie.
Santé publique	Actions collectives destinées à prévenir, protéger et améliorer la santé de populations.
Santé mondiale	Enjeux et coopérations sanitaires qui traversent les frontières.
One Health	Approche intégrée des santés humaine, animale et environnementale.
Déterminant de santé	Facteur biologique, social, comportemental ou environnemental influençant la santé.
OMS	Organisation mondiale de la santé, agence spécialisée du système des Nations unies.
OMD	Objectifs du Millénaire pour le développement : huit objectifs, 2000–2015.
ODD	Objectifs de développement durable : dix-sept objectifs, 2015–2030.
ODD 3	Objectif de santé et de bien-être pour tous à tous les âges.
Indicateur de santé	Mesure de description, surveillance, comparaison ou évaluation d'un phénomène de santé.
Indicateur démographique	Mesure de la structure et du renouvellement d'une population.

Indicateur épidémiologique	Mesure de la fréquence ou de la distribution des maladies et des risques.
Numérateur	Nombre d'événements comptés dans un rapport ou taux.
Dénominateur	Population, naissances vivantes ou temps-personne servant de référence.
Solde naturel	Naissances moins décès au cours d'une période.
Solde migratoire	Entrées de population moins sorties sur un territoire.
Taux brut de natalité	Naissances vivantes / population de référence × 1 000.
Taux brut de mortalité	Décès / population de référence × 1 000.
Standardisation par âge	Méthode ajustant les différences de structure d'âge pour comparer des taux.
Espérance de vie à la naissance	Durée de vie moyenne d'une génération fictive soumise aux taux de mortalité d'une période.
Décès maternel	Décès dû ou aggravé par la grossesse, pendant celle-ci ou jusqu'à 42 jours après sa fin, hors cause accidentelle ou fortuite.
RMM	Rapport de mortalité maternelle : décès maternels / naissances vivantes × 100 000.
Taux maternel	Décès maternels rapportés aux femmes en âge de procréer sur une durée définie.
Mortalité néonatale	Décès de la naissance avant 28 jours de vie.
Mortalité infantile	Décès avant l'âge d'un an (définition Insee/infant mortality).
Mortalité des moins de cinq ans	Décès survenant avant le cinquième anniversaire.
Morbidité	Fréquence ou conséquences des maladies dans une population.
Mortalité	Décès dans une population, exprimés en nombre ou en taux.
Létalité	Part des personnes atteintes d'une maladie qui en décèdent pendant une période donnée.
Prévalence ponctuelle	Part de la population malade à une date T.
Incidence cumulée	Proportion des sujets à risque développant la maladie pendant une période.
Taux d'incidence	Nouveaux cas rapportés à la somme des personnes-temps à risque.
Personne-temps	Quantité de suivi accumulée par les personnes à risque.
MNT	Maladies non transmissibles, notamment cardiovasculaires, cancers, diabète et maladies respiratoires.
Transition épidémiologique	Évolution de la répartition des causes de morbidité et de décès.
VIH	Virus de l'immunodéficience humaine.
Sida	Syndrome d'immunodéficience acquise ; stade avancé de l'infection VIH.
ARV	Antirétroviraux, médicaments qui inhibent la réplication du VIH.
PrEP	Prophylaxie pré-exposition au VIH.
TPE	Traitement post-exposition au VIH.

I = I	Indétectable = intransmissible sexuellement sous suppression virale durable.
Paludisme	Maladie parasitaire due à Plasmodium, principalement transmise par Anopheles.
Vecteur	Organisme assurant la transmission d'un agent pathogène, par exemple un moustique.
Tuberculose latente	Infection tuberculeuse sans maladie active, non contagieuse.
Tuberculose active	Maladie due à Mycobacterium tuberculosis, pouvant être contagieuse si pulmonaire.
Antibiorésistance	Capacité d'une bactérie à résister à un antibiotique.
HTA	Hypertension artérielle, facteur de risque cardiovasculaire.
AVC	Accident vasculaire cérébral.
Infarctus du myocarde	Nécrose d'une partie du muscle cardiaque par ischémie.
Embolie pulmonaire	Obstruction d'une artère pulmonaire, généralement par thrombus veineux.
Incidence du cancer	Nombre de nouveaux diagnostics de cancer sur une période.
Survie nette	Estimation de survie liée au cancer dans un cadre statistique écartant les autres causes de décès.
Dépistage organisé	Programme visant une population cible selon des modalités définies.
Dépistage individuel	Démarche personnalisée en fonction du contexte et des facteurs de risque.
Accès aux soins	Possibilité d'obtenir des soins adaptés ; concept cité au plan du cours.
Recours aux soins	Utilisation effective de services de santé ; concept cité au plan du cours.